EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84361
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 15-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELICIA MOYA ITURRA			**RUN**	: 4.435.328-8
F.Nac	: 15-05-1944	**Edad**	: 80 AÑOS	**Género**	: Femenino
Dirección	: CASA 30 LA RIBERA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 95325353		
Fecha Ingreso	: 2024-05-06	**Fecha Egreso**	: 15-05-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. C18.9-TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Bacteremia
-Hemocultivo + para E Coli BLEE +
-Probable origen urinario: UCT E. coli BLEE
CA de colon en CP
MT Hepática / Urinaria
Anemia crónica moderada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Familiar de paciente refiere inicio de sintomatología hace 2 semanas aproximadamente. Acorde a relato, destaca aumento de temperatura corporal no cuantificada, asociado a compromiso del estado general y dolor abdominal leve a moderado (dentro de contexto de CA descrito previamente).
Durante entrevista, en conversación directa con paciente, refiere dolor abdominal además de disuria franca, pujo y tenesmo vesical. Destaca además leve aumento de volumen de EII, sin dolor a la palpación.
En servicio de urgencias, se valora inicialmente paciente con compromiso del estado general, somnoliente, taquicárdica, hipotensa (80/50mmHg), febril (38.1). Se toman exámenes de laboratorio que reportan:
Crea: 1,40 mg/dl | LDH: 216 U/L | Lact: 5,2 mmol/L | PCR: 315,6 mg/L | Uremia: 87 mg/dl | Na: 140 mmol/L | K: 4,50 mmol/L | Cl: 104 mmol/L | Hb: 7,8 g/dl | Hto: 25,2% | GB: 39,20 mil/ul | GR: 3,34 mil/ul | Plaq: 328 mil/ul
Durante estancia en servicio de medicina se reciben Hemocultivos y urocultivos que sugieren infección por E. Coli BLEE por lo que se ajusta terapia. Ultimos exámenes de control evidencian mejoría desde punto de vista paraclínico con parámetros inflamatorios bajos. Paciente con episodios de hipotensión, recibiendo terapia vs CA en CP con Transtec (parches), además de hipoalimentación con hipoglicemias secundarias, por lo que se decide instalación de SNG.
Completa 7 dias de Meropenem hospitalizada pero con nuevos episodios de alzas térmicas con elevación de parámetros inflamatorios, se decide hemocultivar y urocultivar pero resultados son negativos, panel respiratorio viral negativo, por lo que se presume fiebre de origen neoplásico, por lo que se decide en conjunto con familia manejo en domicilio, a completar 10 días con antibioticos y kinesioterapia, manejo por HODOM y seguimiento por cuidados paliativos.

PLAN DE MANEJO:

En caso de deterioro clínico queda a criterio de familia la evaluación en servicio de urgencias.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo en cama
2. Regimen por sonda nasogastrica según indicación de nutrición
3. Agua por sonda nasogástrica 200cc c 6hrs
4. Limpieza de cavidad oral con clorexidina am y pm
5. Ertapenem 1gr ev por 3 días
6. Dabigatran 110mg vo c12h
7. Paracetamol 1gr vo c 8hrs por sonda nasogastrica
8. Mantener Transtec acorde indicación CP
9. KNT Motora y respiratoria
10. Seguimiento Fonoaudiología
11. Derivo para seguimiento con HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

TC TX:
Cardiomegalia. Ateromatosis cálcica. Engrosamiento de paredes bronquiales. Engrosamiento septal

TC AP:
Lesión de aspecto neoplásico en íleon distal con infiltración del uréter derecho produciendo hidroureteronefrosis secundaria. Quiste hepático. Ateromatosis cálcica. Quistes renales bilaterales de aspecto simple. Fecaloma.

Valoración dirigida de TC impresiona quistes renales izquierdos (mayor de 7-8cm),quistes renal derecho.
Se rescata resultado de Hemocultivo que reporta E. coli BLEE
Urocultivo que reporta E coli BLEE

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO